



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شيماء بحر عثمان محمد

العنوان : اخر فيصل كفر نصار
الهرم الجيزه

الحي / المدينة : اخرى

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 28304280100123 رقم التليفون : 01128187881

العمر(تاريخ الميلاد) : 28-04-1983 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....) المقر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج : الاورام
[11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شيماء بحر عثمان محمد National ID: 28304280100123	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



شيماء
بدر عثمان محمد
آخر فيصل - كفر نصار
الهرم - الجيزة

١٩٨٣/٠٤/٢٨ ٢٨٣.٤٢٨.٠١.٠١٢٣

IG4082198

فرم

١١٢٨١٨٧٨٨١
١٠٣.٦١١٩٧٨

عنى

٢٠١٩/١١ ٢٨٣.٤٢٨.٠١.٠١٢٣
حاصلة على بكالوريوس علوم زراعية

أنثى
مسلمة
عماد رجب عثمان بشير
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٦/١١/١٧

متزوجة





Shaimaa Bahr Oathman Mohamed : اسم المريض بالإنجليزية	98977 : كود المريض
2026/09/02 10:31:19 AM : تاريخ التقرير	السن: ٤٣ سنة ٣ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 43 y old lady coming for routine screening.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Extremely dense mammary parenchyma (ACR D).
- Diffuse parenchymal distortion involving whole breast quadrants associated with multiple suspicious clusters of micro calcifications detected on right UOQ ,Upper central and UIQ.
- **Ultrasound** diffuse infiltrative process with distortion affecting UOQ ,LOQ and UIQ.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Right axillary pathological lymph nodes (about three seen at level I) The largest is seen measuring 2 cm in its long with cortical thickness 6.5 mm .
- Right infraclavicular small lymph node 7 mm in its long axis .

Left breast

- Extremely dense mammary parenchyma (ACR D).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid lesions.
- Few scattered anechoic cysts with dilated retroareola ducts
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 5): Right diffuse malignant process with malignant microcalcification and ipsilateral pathological nodes .

Left breast (BIRADS 2): Mild ductectasia and fibrocystic changes.

Recommendations:

Right Biopsy and Histopathological correlation

Dr.Heba Ahmed ,MD



رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-9-2

الى من يهمه الامر

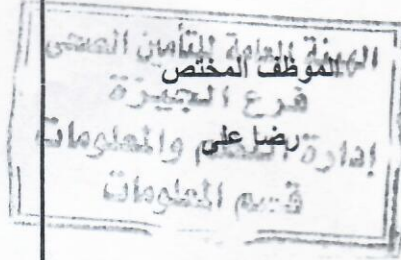
الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) شيماء بحر عثمان بطاقة رقم 28304280100123

تليفون رقم: 01128187881

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفحه بالتأمين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-9-2



افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،



مسلسل 2068201

الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناتيونال - مختبر معمل الباثولوجي



Patient Name	شيماء بر عثمان	Case No.	362424
Sex/Age	Female 43 Y	Patient No.	26680
Registered Date	03/9/2026 03:23:09 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	24/9/2026 11:08:32 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:42:32 AM	Pathology No.	2861/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 3/09/2026, Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

Four greyish, white tissue cores, ranging in size between 1.0 - 2.7cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Present.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 85% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 10%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).



شركة رقم (4) - الطور الثاني - مبنى رقم (987) - مركز فنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة 5 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nisar El Qadima - Cairo, Egypt

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي القريظونيل - مصر-معمل الباثولوجي

Patient Name	شياء بر عثمان	Case No.	362424
Sex/Age	Female 43 Y	Patient No.	26680
Registered Date	03/9/2026 03:23:09 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	24/9/2026 11:08:32 AM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	30/9/2026 10:42:32 AM	Pathology No.	2861/26

- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).
- Ki67%: 10%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature**Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.**خريطة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة 2 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qanlica - Cairo, Egypt

Shaimaa Bahr Oathman Mohamed : اسم المريض بالإنجليزية	98977 : كود المريض
2026/09/02 10:31:19 AM : تاريخ التقرير	السن: ٣٣ سنة ٤ شهر

Women's Health Outreach Program Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: 43 y old lady coming for routine screening.

Technique

Medio-lateral oblique and CC views High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Extremely dense mammary parenchyma (ACR D).
- Diffuse parenchymal distortion involving whole breast
- quaderants associated with multiple suspicious clusters of micro calcifications detected on right UOQ, Upper central and UIQ.
- **Ultrasound** diffuse infiltrative process with distortion affecting UOQ, LOQ and UIQ.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Right axillary pathological lymph nodes (about three seen at level I) The largest is seen measuring 2 cm in its long with cortical thickness 6.5 mm.
- Right infraclavicular small lymph node 7 mm in its long axis.

Left breast

- Extremely dense mammary parenchyma (ACR D).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid lesions.
- Few scattered anechoic cysts with dilated retroareola ducts
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Preserved axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 5): Right diffuse malignant process with malignant microcalcification and ipsilateral pathological nodes.

Left breast (BIRADS 2): Mild ductectasia and fibrocystic changes.

Recommendations:

Right Biopsy and Histopathological correlation

Dr.Heba Ahmed ,MD